BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình tiếp nhận và quản lý người bệnh điều trị nội trú

Bản hoàn thiện để trình thẩm định năm 2026

Quy trình phân công việc tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi và bàn giao người bệnh từ khi vào khoa nội trú đến khi ra viện, chuyển khoa hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ưu tiên xử trí tình trạng cấp cứu và bảo đảm chăm sóc liên tục trong mọi bước.

Thông tin quản lý	Nội dung
Mã quy trình đề xuất	QT.01.ĐD — xác nhận trong danh mục tài liệu của bệnh viện
Phiên bản	Bản trình thẩm định 2026; ngày rà soát 13/10/2026
Ngày ban hành và hiệu lực	……/……/……; điền sau khi phê duyệt
Đơn vị chủ trì	Phòng Điều dưỡng
Nơi nhận	Ban Giám đốc; Phòng Điều dưỡng; Phòng Kế hoạch tổng hợp; bộ phận Quản lý chất lượng; các khoa lâm sàng và cận lâm sàng; các bộ phận liên quan

Trách nhiệm	Soạn thảo	Thẩm định	Phê duyệt
Họ và tên	……	……	……
Chức vụ	……	……	……
Chữ ký và ngày	……	……	……

Chưa xác nhận người ký, số quyết định, ngày hiệu lực và các mốc thời gian nội bộ. Tài liệu chỉ trở thành quy trình áp dụng sau khi người có thẩm quyền phê duyệt. Không sử dụng chữ ký hoặc tên người ký của bệnh viện nguồn.

I Mục đích

Thống nhất việc tiếp nhận và quản lý người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân; phòng ngừa nhầm người bệnh, bỏ sót diễn biến, gián đoạn chăm sóc và thiếu thông tin khi bàn giao. Làm rõ trách nhiệm của bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, hộ lý và các bộ phận hỗ trợ.

II Phạm vi áp dụng

Áp dụng tại các khoa có giường điều trị nội trú và các đơn vị phối hợp, trong phạm vi hoạt động được cấp phép của bệnh viện. Điều dưỡng, hộ sinh thực hiện theo vị trí được phân công và phạm vi hành nghề. Quy trình chuyên khoa được bổ sung phù hợp nhưng phải bảo đảm các yêu cầu tiếp nhận và bàn giao an toàn của quy trình này.

III Tài liệu tham khảo và căn cứ áp dụng

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; đối chiếu quyền và nghĩa vụ của người bệnh, hồ sơ bệnh án, cấp cứu và điều trị nội trú.

2. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; trọng tâm Điều 5 đến Điều 7 về tiếp nhận, nhận định, can thiệp và đánh giá chăm sóc.

3. Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023, Chương X về hồ sơ bệnh án, sử dụng phần còn hiệu lực và biểu mẫu hiện hành. Văn bản đã hết hiệu lực một phần; không mặc nhiên dùng mọi phụ lục của bản ban đầu.

4. Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện xác nhận quy trình vận hành, xác nhận điện tử và phương án khi hệ thống gián đoạn.

5. Thông tư 18/2024/TT-BYT ngày 01/10/2024 bãi bỏ một số nội dung của QĐ 1895/1997/QĐ-BYT. Không dùng các mục đã bãi bỏ về chẩn đoán, hồ sơ bệnh án, hội chẩn hoặc xử lý người bệnh tử vong làm căn cứ độc lập.

6. Quy định và quy trình đã được bệnh viện phê duyệt về nhận diện người bệnh, chăm sóc, thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao, chuyển viện, ra viện và báo cáo sự cố. Phòng Điều dưỡng điền mã và phiên bản hiện hành khi ban hành.

QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 được áp dụng cho các quy trình kỹ thuật riêng liên quan theo yêu cầu của bệnh viện. Tài liệu này là quy trình tổ chức tiếp nhận và quản lý nội trú, giữ cấu trúc quản lý của bản nguồn; các thao tác kỹ thuật được dẫn chiếu đến quy trình kỹ thuật phù hợp, không mô tả thay toàn bộ kỹ thuật ở đây.

IV Thuật ngữ và từ viết tắt

Người bệnh nội trú là người bệnh phải lưu lại cơ sở để khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ định. Bàn giao là chuyển thông tin và trách nhiệm chăm sóc giữa nhân viên hoặc đơn vị, có xác nhận người giao và người nhận. Người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ trong phạm vi đại diện theo pháp luật; không mặc nhiên coi mọi người nhà đều có quyền quyết định thay người bệnh.

Viết tắt	Giải thích
NB	Người bệnh
BS	Bác sĩ
ĐD	Điều dưỡng
ĐDT	Điều dưỡng trưởng
HSBA	Hồ sơ bệnh án
KHCS	Kế hoạch chăm sóc
CLS	Cận lâm sàng
SBAR	Tình huống — thông tin nền — đánh giá — đề nghị

V Nội dung quy trình

1 Trách nhiệm

Vị trí	Trách nhiệm chính
Ban Giám đốc	Phê duyệt quy trình, phân công nhân lực và nguồn lực; giải quyết tình huống vượt thẩm quyền khoa.
Trưởng khoa và bác sĩ	Quyết định chuyên môn; khám, chỉ định, điều trị, hội chẩn, chuyển và ra viện; giải thích thông tin và ghi HSBA.
Phòng Điều dưỡng và ĐDT	Phân công, hướng dẫn và kiểm tra việc tiếp nhận, chăm sóc, ghi chép, bàn giao; điều phối khi thiếu nguồn lực.
ĐD hoặc hộ sinh được phân công	Tiếp nhận, nhận định nhu cầu và nguy cơ; phối hợp phân cấp chăm sóc, thực hiện KHCS và y lệnh, theo dõi và bàn giao.
Hộ lý và nhân viên hỗ trợ	Hỗ trợ vệ sinh, đồ vải, vận chuyển theo phân công và hướng dẫn; không thay nhân viên chuyên môn thực hiện thao tác vượt nhiệm vụ.
Hành chính, viện phí, CNTT và đơn vị liên quan	Cập nhật thông tin, hỗ trợ thủ tục, công khai chi phí, duy trì hệ thống và phối hợp bàn giao đúng chức năng.

2 Nguyên tắc an toàn

Tiếp nhận và đánh giá ngay khi NB đến khoa. Nếu có dấu hiệu cấp cứu hoặc diễn biến nguy hiểm, gọi BS và đội hỗ trợ, xử trí theo quy trình cấp cứu; không chờ hoàn thành giấy tờ, đóng tạm ứng hoặc đủ chữ ký mới chăm sóc. Thiếu giường hoặc sai khoa tiếp nhận phải báo người có thẩm quyền điều phối và giữ trách nhiệm theo dõi đến khi bàn giao an toàn.

Quy ước nội bộ đề xuất: đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận diện, như họ tên và ngày sinh hoặc mã NB, với hồ sơ và phương tiện nhận diện trước can thiệp, lấy mẫu và bàn giao. Không dùng số giường hay số phòng làm thông tin nhận diện duy nhất. Người bệnh trùng tên có cảnh báo phù hợp; sắp xếp giường theo nhu cầu chăm sóc và kiểm soát nhiễm khuẩn.

NB được giải thích rõ, tôn trọng riêng tư và hỗ trợ giao tiếp. Chấp thuận can thiệp được thực hiện theo loại can thiệp và quy định pháp luật; chữ ký nhận nội quy không thay thế chấp thuận điều trị, không dùng cam kết chung để miễn trách nhiệm của bệnh viện.

3 Trình tự thực hiện

Bước 1 Tiếp đón và nhận bàn giao

Người thực hiện: ĐD tiếp đón hoặc ĐD trực

Chào hỏi, giới thiệu tên và chức danh; kiểm tra chỉ định nhập khoa và thông tin nhận diện. Nhận bàn giao trực tiếp từ đơn vị chuyển khi có bàn giao chuyên môn; ghi thời điểm NB đến khoa.

Đánh giá nhanh tình trạng hiện tại. Nhận thông tin chẩn đoán, dị ứng, nguy cơ, thuốc và can thiệp đã dùng, thiết bị đang mang, kết quả hoặc y lệnh còn chờ. Nếu thông tin thiếu hoặc không khớp, phối hợp xác minh ngay, vẫn ưu tiên chăm sóc cấp cứu.

Sắp xếp giường phù hợp; báo BS và nhân viên phụ trách, nhập sổ hoặc hệ thống. Hướng dẫn nội quy, kênh gọi hỗ trợ và những thủ tục cần bổ sung khi NB ổn định.

Bước 2 Tiếp nhận tại giường

Người thực hiện: ĐD hoặc hộ sinh phụ trách

Nhận định tình trạng ý thức, hô hấp, tuần hoàn, đau và các nhu cầu chăm sóc; đo sinh hiệu, cân nặng, chiều cao khi phù hợp, không trì hoãn cấp cứu để hoàn thành các phép đo không cấp thiết.

Ghi dị ứng và phản ứng đã biết; khai thác thuốc đang dùng, bệnh kèm, khả năng vận động và giao tiếp. Sàng lọc nguy cơ té ngã, tổn thương do tỳ đè, dinh dưỡng và các nguy cơ chuyên khoa theo công cụ bệnh viện phê duyệt.

Phối hợp BS nhận định, phân cấp chăm sóc và xác định mức theo dõi. Hướng dẫn sử dụng thiết bị, gọi nhân viên hỗ trợ, vệ sinh tay và an toàn buồng bệnh; ghi vấn đề cần xử lý ngay.

Bước 3 Khám và ra y lệnh

Người thực hiện: BS điều trị hoặc BS trực

Khám theo mức độ khẩn cấp; ghi thời điểm khám, đánh giá, chẩn đoán và y lệnh. Giải thích bệnh, kế hoạch điều trị, lựa chọn can thiệp và chi phí liên quan theo nhiệm vụ chuyên môn.

NB ổn định: đề xuất bệnh viện phê duyệt mục tiêu BS khám và ra y lệnh ban đầu không quá 1 giờ từ khi đến khoa; NB cần cấp cứu phải được xử trí ngay. Mốc 1 giờ này là mục tiêu nội bộ của dự thảo, không được diễn giải thành thời gian cho phép chờ ở ca cấp cứu.

Lập, cập nhật HSBA ngay theo diễn biến và biểu mẫu hiện hành. Các mốc 24 giờ, 36 giờ trong bản nguồn cần được bệnh viện đối chiếu quy định quản lý hồ sơ đang áp dụng trước khi đưa thành thời hạn bắt buộc. Không chờ đến hạn mới ghi hoạt động đã thực hiện.

Bước 4 Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc

Người thực hiện: ĐD hoặc hộ sinh phụ trách

Xác định vấn đề chăm sóc, mục tiêu, can thiệp, người thực hiện và thời điểm đánh giá; ưu tiên vấn đề đe dọa an toàn. Ghi KHCS và điều chỉnh khi tình trạng hoặc nhu cầu thay đổi.

Kiểm tra và thực hiện y lệnh trong phạm vi chuyên môn. Y lệnh không rõ hoặc có nguy cơ sai sót phải được xác minh với BS; quản lý thuốc theo quy trình sử dụng thuốc của bệnh viện.

Theo dõi đáp ứng, giáo dục sức khỏe phù hợp khả năng NB, ghi thời điểm và người thực hiện; báo BS ngay khi có bất thường. Các kỹ thuật tiêm, truyền, lấy mẫu và kỹ thuật khác thực hiện theo quy trình riêng được phê duyệt.

Bước 5 Hỗ trợ chăm sóc và vận chuyển

Người thực hiện: Hộ lý hoặc nhân viên được phân công

Chuẩn bị đồ vải, vệ sinh buồng bệnh và hỗ trợ NB theo hướng dẫn. Phối hợp hướng dẫn giữ vệ sinh, trật tự và phân loại chất thải.

Trước đi CLS, ĐD kiểm tra tình trạng, yêu cầu theo dõi, phương tiện và nhân viên đi kèm. NB cần theo dõi hoặc có nguy cơ diễn biến phải có nhân viên chuyên môn phù hợp; hộ lý không thay nhiệm vụ theo dõi chuyên môn.

Bàn giao tại nơi đến và nhận lại khi NB trở về; kiểm tra đường truyền, thiết bị và thông tin kết quả hoặc việc còn chờ.

Bước 6 Theo dõi trong quá trình điều trị

Người thực hiện: BS, ĐD và lãnh đạo khoa

BS đánh giá diễn biến và điều chỉnh điều trị. ĐD theo dõi theo mức độ bệnh, phân cấp chăm sóc và y lệnh; nhận định lại khi có thay đổi. ĐDT đi buồng, kiểm tra chăm sóc và điều phối nguồn lực.

Có diễn biến nặng, điều trị không đáp ứng, chưa rõ chẩn đoán hoặc vượt khả năng: báo BS và lãnh đạo khoa, xem xét hội chẩn hoặc chuyển phù hợp ngay. Không dùng mốc 48 giờ của bản nguồn làm điều kiện để chờ hội chẩn.

Mỗi ca trực bàn giao bằng hồ sơ và trao đổi trực tiếp theo tình trạng; nêu rõ nguy cơ, thuốc, can thiệp, việc còn chờ và thời điểm phải theo dõi lại. Người nhận xác nhận và làm rõ nội dung chưa đủ.

Bước 7 Chuẩn bị ra viện hoặc chuyển

Người thực hiện: BS, ĐD chăm sóc và bộ phận hành chính

BS quyết định và ghi chỉ định ra viện hoặc chuyển; giải thích lý do và kế hoạch tiếp theo. Với trường hợp dự kiến được, thông báo sớm để NB và đơn vị nhận chuẩn bị; đề xuất mục tiêu thông báo trước 24 giờ khi phù hợp, không áp dụng để trì hoãn chuyển cấp cứu.

ĐD kiểm tra y lệnh cần hoàn thành, kết quả còn chờ, thuốc và thiết bị; phối hợp hành chính đối chiếu chi phí và thông tin giấy tờ. Giáo dục tự chăm sóc, thuốc theo đơn, dấu hiệu cần khám ngay và lịch tái khám; đề nghị NB nhắc lại để kiểm tra hiểu.

Chuyển khoa hoặc cơ sở: liên hệ nơi nhận, chuẩn bị tóm tắt thông tin, phương tiện, nhân viên đi kèm và xử trí trước chuyển theo tình trạng.

Bước 8 Hoàn tất và bàn giao

Người thực hiện: BS, ĐD và các bộ phận liên quan

Ra viện: giao giấy tờ và hướng dẫn theo quy định, xác nhận người nhận; trả đồ cá nhân, thu hồi đồ mượn và cập nhật kết thúc đợt điều trị. Phối hợp giải quyết thủ tục và khó khăn theo thẩm quyền.

Chuyển: ghi thời điểm, tình trạng trước chuyển, thông tin và thiết bị đi kèm, nơi nhận, người giao và người nhận. Trách nhiệm chăm sóc được duy trì đến khi có bàn giao; bố trí theo dõi trong quá trình vận chuyển theo mức độ bệnh.

NB tử vong, tự ý rời khoa hoặc từ chối điều trị: thực hiện quy trình riêng và quy định hiện hành, báo người có thẩm quyền, ghi đầy đủ diễn biến và tư vấn đã thực hiện; không dùng thủ tục ra viện thông thường thay cho các tình huống này.

4 Ghi chép và quản lý hồ sơ

Ghi chính xác, kịp thời, rõ thời điểm và người thực hiện. Bảo vệ thông tin cá nhân, phân quyền truy cập và sửa thông tin theo quy định; không ghi lùi giờ hoặc dùng tài khoản người khác. Khi hệ thống gián đoạn, sử dụng biểu mẫu dự phòng được bệnh viện phê duyệt, bảo quản và cập nhật lại có đối chiếu, giữ dấu vết thời điểm ghi ban đầu.

Các phiếu ở phụ lục là công cụ kiểm tra hoặc hỗ trợ bàn giao; không thay hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc, giấy chuyển và các mẫu bắt buộc. Bệnh viện quản lý biểu mẫu, thời hạn bảo quản và người chịu trách nhiệm theo hệ thống tài liệu đang áp dụng.

5 Kiểm tra và triển khai

Phòng Điều dưỡng phối hợp Quản lý chất lượng hướng dẫn nhân viên trước triển khai; ĐDT kiểm tra trong đi buồng và bàn giao. Đề xuất rà soát mẫu hồ sơ hằng tháng, phản hồi thiếu sót, giao người khắc phục và đánh giá lại. Các tần suất này là đề xuất nội bộ cần được phê duyệt.

Theo dõi tỷ lệ tiếp nhận có đủ nhận diện và nhận định ban đầu; tỷ lệ bàn giao có người nhận xác nhận; tỷ lệ NB ra viện có hướng dẫn và kiểm tra hiểu. Mỗi tỷ lệ bằng số trường hợp đáp ứng trong mẫu chia tổng trường hợp đủ điều kiện trong cùng mẫu × 100%. Mẫu số bằng 0 ghi không áp dụng; không thay dữ liệu thiếu bằng 0.

Phụ lục 1 Bảng kiểm tiếp nhận tại khoa

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN — Khoa: ……

Họ tên NB: …… Ngày sinh: …… Mã NB: ……

Thời điểm đến khoa: …… Nơi chuyển: …… Người tiếp nhận: ……

STT	Nội dung	Kết quả và ghi chú
1	Chỉ định và thông tin nhận diện được đối chiếu	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
2	Tình trạng khẩn cấp được nhận định và xử trí ưu tiên khi có	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
3	Thông tin bàn giao gồm dị ứng, nguy cơ, thuốc và việc còn chờ	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
4	BS và nhân viên phụ trách được thông báo	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
5	Giường, phương tiện và yêu cầu phòng ngừa nhiễm khuẩn phù hợp	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
6	Sinh hiệu, nhu cầu chăm sóc và nguy cơ được nhận định	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
7	Kế hoạch theo dõi và chăm sóc ban đầu được xác định	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
8	NB hoặc đại diện được hướng dẫn gọi hỗ trợ và nội quy	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
9	Thông tin tiếp nhận và bàn giao được ghi, có người nhận xác nhận	Đạt / Chưa đạt / KAD ……

KAD: không áp dụng; phải nêu lý do. Việc chưa hoàn thành: ……

Người xử lý và hạn hoàn thành: …… Người kiểm tra: ……

Phụ lục 2 Phiếu hỗ trợ bàn giao

Họ tên NB: …… Ngày sinh: …… Mã NB: ……

Khoa giao: …… Khoa hoặc cơ sở nhận: …… Thời điểm: ……

Tình huống

Lý do bàn giao, tình trạng và mức khẩn cấp: ……

……

Thông tin nền

Chẩn đoán, dị ứng, bệnh kèm, can thiệp và thuốc đã dùng: ……

……

Đánh giá

Sinh hiệu gần nhất và thời điểm đo, ý thức, đau, diễn biến và nguy cơ: ……

……

Đề nghị

Việc cần làm, thuốc hoặc kết quả còn chờ, thời điểm theo dõi lại: ……

……

Đường truyền, dẫn lưu, thiết bị, oxy và phương tiện đi kèm: ……

Hồ sơ, kết quả và tài sản bàn giao: ……

Nhân viên đi kèm và phương tiện vận chuyển khi cần: ……

Người giao ký ghi họ tên: …… Người nhận ký ghi họ tên: ……

Thời điểm nơi nhận tiếp nhận và tình trạng khi nhận: ……

Phụ lục 3 Bảng kiểm trước ra viện hoặc chuyển

Họ tên NB: …… Ngày sinh: …… Mã NB: ……

Hình thức: Ra viện / Chuyển khoa / Chuyển cơ sở. Thời điểm: ……

STT	Nội dung	Kết quả và ghi chú
1	Có chỉ định và thông tin người bệnh được đối chiếu	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
2	Đã đánh giá tình trạng và hoàn thành can thiệp cần thiết	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
3	Thuốc, kết quả còn chờ và trách nhiệm theo dõi được làm rõ	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
4	Đã hướng dẫn tự chăm sóc, dấu hiệu cần khám ngay và tái khám khi ra viện	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
5	Đã kiểm tra người bệnh hoặc đại diện hiểu hướng dẫn	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
6	Giấy tờ, đơn thuốc, thông tin chuyển được giao đúng người	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
7	Nơi nhận, phương tiện và nhân viên đi kèm phù hợp khi chuyển	Đạt / Chưa đạt / KAD ……
8	Bàn giao được xác nhận; hồ sơ và dữ liệu được cập nhật	Đạt / Chưa đạt / KAD ……

Vấn đề chưa hoàn thành và người chịu trách nhiệm: ……

Người thực hiện: …… Người kiểm tra: ……

Theo dõi sửa đổi và nguồn đối chiếu

Nội dung bản nguồn	Điều chỉnh trong bản Nhật Tân
Tên bệnh viện và người ký Quảng Trị	Đổi sang Nhật Tân; để trống người ký và ngày hiệu lực chờ xác nhận.
Căn cứ QĐ 1895 ghi sai ngày và số	Không dùng căn cứ lỗi; cập nhật Luật 15, TT31, phần còn hiệu lực TT32, TT13 và đối chiếu TT18.
Tránh xếp người trùng tên cùng phòng	Chuyển thành đối chiếu nhận diện và cảnh báo phù hợp, không lấy phân phòng làm biện pháp duy nhất.
Mốc khám và hồ sơ, hội chẩn 48 giờ	Phân biệt mục tiêu nội bộ và căn cứ hiện hành; xử trí và hội chẩn theo tình trạng, không chờ mốc 48 giờ.
Thông báo ra hoặc chuyển trước 24 giờ	Chỉ áp dụng mục tiêu đề xuất cho trường hợp dự kiến được; ưu tiên chuyển khẩn cấp.
Thiếu bằng chứng bàn giao và kiểm tra	Bổ sung 3 biểu mẫu hỗ trợ tiếp nhận, bàn giao và ra hoặc chuyển.

Trước ban hành, xác nhận mã tài liệu, người ký, thời hạn khám và ghi hồ sơ, phương tiện nhận diện, biểu mẫu điện tử, phương án gián đoạn, đầu mối điều phối và quy trình liên quan của Nhật Tân. Giữ nguyên file nguồn để đối chiếu.

Luật 15/2023/QH15 — https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm

Thông tư 31/2021/TT-BYT — https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

Thông tư 32/2023/TT-BYT — https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=167907

Thông tư 13/2025/TT-BYT — https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=178219

Thông tư 18/2024/TT-BYT — https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170589

Nguồn nghiệp vụ ban đầu: QT_01_DD_Quy_trinh_tiep_nhan_va_quan_ly_nguoi_benh_dieu_tri_noi_tru.doc, bản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019 do người dùng cung cấp. Ngày đối chiếu nguồn công khai: 13/10/2026.